

10 - 05- Diverticulose colique - Pr. Oubaha

(0:00 - 0:33)

Bonjour, le cours d'aujourd'hui s'intitule Diverticulose colique. Comme à notre accoutumée, les objectifs pédagogiques que l'étudiant devra connaître à la fin du cours, c'est essentiellement d'être capable de mener une enquête diagnostique devant une diverticulose colique, d'identifier les situations d'urgence et de proposer une attitude thérapeutique, ainsi que de planifier le suivi de ses patients. Pour arriver à ces objectifs pédagogiques, nous allons adopter le plan suivant.

(0:36 - 0:56)

Donc, cette diverticulose colique n'est rien d'autre qu'une anomalie anatomique. C'est une anomalie anatomique qui est très fréquente et qui correspond à la formation de petits sacs herniérés à travers la couche musculaire du colon. Dans 70% des cas, cette anomalie reste asymptomatique et donc elle ne va nécessiter aucun traitement.

(0:58 - 1:28)

Malheureusement, chez 30% des patients porteurs de diverticulose, celle-ci va se compliquer. Et en se compliquant, on parle de maladie diverticulaire qui va regrouper cet ensemble de complications qui, elles, auront une traduction clinique et nécessiteront une prise en charge thérapeutique. D'un point de vue épidémiologique, puisque la diverticulose reste asymptomatique, sa prévalence réelle est très difficile à identifier et à connaître.

(1:29 - 1:49)

On sait que sa prévalence augmente avec l'âge, puisque plus de 70% des patients de plus de 80 ans ont une diverticulose. On sait aussi qu'elle prédomine dans la population occidentale et ceci dépend du régime alimentaire de ces populations. Et on sait également que l'obésité est un facteur de risque de cette diverticulose.

(1:50 - 2:15)

D'un point de vue anatomique, et c'est d'ailleurs ce qui définit la diverticulose colique, c'est une hernie qui est constituée à travers la paroi du colon. Donc ces hernies vont se constituer au niveau des points de faiblesse. Au niveau du colon, les points de faiblesse, au niveau de la paroi colique, les points de faiblesse sont les points de pénétration des vaisseaux sanguins et donc les points de pénétration des vasa recta.

(2:15 - 3:04)

C'est ce qui permet également d'expliquer que les diverticules vont surtout se localiser au niveau des bandelettes coliques, puisque c'est le point de pénétration de la vascularisation. Alors c'est

ce qui est illustré au niveau de ce schéma, puisque comme vous le voyez, le point de pénétration du vaisseau, c'est le point de faiblesse de la paroi, qui va faire que la muqueuse va cerner à travers la musculature et on aura un diverticule dont la paroi sera constituée de la muqueuse et de la musculature et il n'y aura pas de musculature. Cette composition de la paroi du diverticule faite de muqueuse, de musculature et avec le vaisseau qui traverse expliquera plusieurs manifestations et plusieurs complications qu'on verra au fur et à mesure.

(3:05 - 3:28)

De même que l'absence de la musculature est également un facteur physiopathologique des complications de la maladie diverticulaire. Le nombre de diverticules est très variable, puisque les patients peuvent avoir un ou plusieurs diverticules, ça peut aller à une centaine de diverticules. Leur taille est également très variable, ça peut aller de quelques millimètres à plus de 2 centimètres.

(3:28 - 4:06)

Ils sont souvent localisés au niveau du sigmoïde, mais il faut savoir que tout le colon peut contenir des diverticules et que quand la teinte est localisée au colon droit, ça reste quand même très limité et beaucoup plus rare que la teinte du colon gauche. La physiopathologie de la constitution de ces diverticules coliques est imparfaitement connue, mais il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont incriminé un certain mécanisme. Il faut savoir que ça commence par un régime pauvre en fibres.

(4:07 - 4:46)

Le régime pauvre en fibres sera à l'origine d'une diminution du poids des selles. La diminution du poids des selles va entraîner une augmentation du temps de transit colique et par conséquent, il va y avoir une augmentation de la contractilité colique pour pousser ces selles qui ont un poids réduit et qui, puisqu'ils ont séjourné longtemps dans le colon, vont également être desséchées. Ceci va être à l'origine d'une augmentation de la pression intracolique et cette augmentation de la pression intracolique va favoriser la formation des diverticules à travers les points de faiblesse.

(4:46 - 5:06)

C'est ce qui est schématisé sur ce schéma. Le poids des selles, l'augmentation de la contractilité, forcément l'augmentation de la pression et par conséquent, la formation d'un diverticule à travers les points de faiblesse. Ceci va nous faire parler des facteurs protecteurs ou facteurs favorisants.

(5:06 - 5:22)

Tout d'abord, les fibres alimentaires. Si on a un régime qui est pauvre en fibres, ça devient un facteur favorisant la constitution des diverticules. Par contre, le régime riche en fibres est un

facteur protecteur de la formation des diverticules.

(5:22 - 6:01)

L'âge. Plus on est jeune, moins on a de risques d'avoir de constitution de diverticules. Les facteurs génétiques.

Si on est dans une famille où la constitution de diverticules se fait en fonction de l'âge, on sera prédisposé à avoir des diverticules. Comment on va prendre en charge cette diverticulose colique ? Comme on a dit, la diverticulose colique non compliquée, ce n'est pas une maladie, mais c'est une anomalie anatomique. Elle est par définition asymptomatique, donc on n'aura pas de symptômes ou de circonstances de découverte.

(6:01 - 6:34)

Souvent, le diagnostic est fait de façon fortuite pour une coloscopie qui est faite pour une autre raison. Par conséquent, il n'y a pas d'examen complémentaire à demander et il n'y a pas de traitement à proposer. C'est vrai que le patient peut avoir des manifestations de troubles fonctionnels intestinaux qu'il faudra traiter, puisque c'est souvent des patients qui ont de la constipation, mais il faut savoir qu'aucune étude n'a formellement démontré une relation de cause à effet entre la présence de diverticules et une symptomatologie de TFI.

(6:35 - 6:51)

Donc, la diverticulose non compliquée ne nécessitera aucune prise en charge thérapeutique. Par contre, il faudra traiter et lutter contre cette constipation pour les patients constipés. C'est l'aspect endoscopique des diverticules.

(6:51 - 7:05)

Vous voyez que ça a l'aspect de petits orifices au niveau de la paroi du colon. Le nombre et la taille restent très variables d'un patient à un autre. Maintenant, cette diverticulose peut se compliquer.

(7:05 - 7:41)

Les complications sont toutes liées à l'ulcération de la muqueuse diverticulaire par les matières fécales contenues dans le diverticule. Comme on a dit au départ, cette muqueuse colique qui va cerner et constituer le diverticule, elle va être toujours capable d'absorber l'eau et les électrolytes. La paroi du diverticule ne va pas comporter de musculature qui va permettre de pousser et d'éliminer ces selles qui vont devenir de plus en plus dures.

(7:42 - 7:57)

Ils peuvent léser la paroi du diverticule et être à l'origine d'une inflammation, d'une infection. Cette infection avec la lésion peut être de différents grades. Il y a aussi le vaisseau, si vous vous rappelez du schéma.

(7:57 - 8:17)

Et donc, ça peut aussi être érodé et il peut saigner. C'est ce qui définit la maladie diverticulaire qui correspond aux complications de la diverticulose colique. Et ces complications sont la diverticulite qui correspond à l'inflammation, à l'infection.

(8:17 - 8:43)

Et bien sûr, ces complications qui peuvent aller de la péritonite à l'abcès, aux fistules et aux sténoses et bien sûr à l'hémorragie. Donc, c'est ce qui est schématisé sur cet diapositif. On va voir que les formes compliquées commencent par le dessèchement des selles au niveau du sac diverticulaire.

(8:43 - 8:55)

Les selles qui sont dures peuvent léser la paroi et être à l'origine d'une hémorragie. Elles peuvent entraîner une inflammation. Cette inflammation va évoluer de façon différente.

(8:56 - 9:14)

L'inflammation sera à l'origine d'un état inflammatoire local. Parfois, une perforation qui sera à l'origine d'une péritonite ou la formation de fistules. Tout commence par l'ulcération diverticulaire.

(9:15 - 9:48)

Cette ulcération diverticulaire entraînera l'hémorragie, de là l'infection et les différentes formes de complications que peut subir un diverticule colique où une maladie est entraînée et rentrée par conséquent dans la maladie diverticulaire. Ces complications peuvent être de type infectieuse. C'est le type de complications qui peut représenter jusqu'à 25% des patients porteurs de diverticulose colique.

(9:48 - 10:18)

Comme on a vu, c'est l'obstruction du diverticule par ces selles qui sont dures qui va entraîner la pullulation microbienne et qui sera à l'origine d'une inflammation voire d'une perforation. La taille de cette perforation va directement être corrélée aux manifestations cliniques. S'il y a une microperforation, ça va entraîner uniquement une inflammation pericolique et c'est la diverticulite sigmoïdienne ou diverticulite colique.

(10:19 - 10:44)

Par contre, si la perforation est plus large, on peut avoir un abcès, une fistule ou même une péritonite. Ceci est à l'origine d'une classification qui s'intéresse à ces complications perforatives. Cela s'appelle la classification en fonction de la gravité de Heimsch.

(10:47 - 11:10)

Elle part du stade 0 où c'est le diverticule non compliqué au stade 4 où il y a carrément une péritonite stercorale généralisée. Ces complications infectieuses vont se manifester par une anorexie, par des douleurs de la fossiliaque. Ce sont les principaux signes d'une inflammation diverticulaire.

(11:11 - 11:44)

Sur le plan biologique, on va trouver des signes infectieux représentés par l'hyperleucocytose. Cela peut parfois faire évoquer un tableau de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, d'appendicite et même, comme diagnostic différentiel, la pathologie cancéreuse compliquée. Devant cette manifestation, la TDM va identifier la localisation de façon fiable de l'inflammation et permet également de visualiser les diverticules inflammées et les tissus péricoliques.

(11:46 - 12:26)

Au cours d'une poussée de diverticulite, la présence de signes de gravité, notamment sur la TDM, qui sont l'air ou la sortie de produits de contraste de façon extra-digestive, l'existence d'un abcès ou d'une fiscule, sont des facteurs de mauvais pronostic et surtout des facteurs de risque de récurrence de ces complications. Il faut aussi savoir que quand ces complications surviennent chez des sujets qui ont moins de 50 ans, c'est également un facteur de risque de chirurgie puisque la récurrence va survenir à moyen voire à long terme. L'autre complication, c'est les sténoses inflammatoires.

(12:26 - 13:12)

Et là, les sténoses coliques inflammatoires, c'est une conséquence classique mais qui reste très rare dans le cadre de la maladie diverticulaire puisqu'on ne la voit qu'environ 10% des causes d'occlusion colique. C'est vrai que sa physiopathie est liée surtout à la récurrence des poussées de diverticulite puisque plus le patient va faire de poussées de diverticulite, plus la cicatrisation peut se faire sous forme de fibrose et plus elle entraînera l'apparition de ces sténoses coliques après plusieurs épisodes de diverticulite. Le principal diagnostic différentiel est de faire la part entre les sténoses tumorales, notamment les adhérents au carcinome colique.

(13:13 - 13:33)

C'est pour ça qu'il faut toujours faire un examen endoscopique et des biopsies devant ces sténoses. L'autre type de complications, c'est les complications hémorragiques. Et là aussi, ce sont des complications qui sont plus rares que les complications infectieuses puisque là, c'est

pratiquement 15% des patients.

(13:34 - 14:10)

C'est toutefois une cause très fréquente d'hémorragie de rectorragie puisque c'est pratiquement 40% des rectoragies, surtout chez les sujets AV, sont secondaires à ces hémorragies diverticulaires. Souvent, c'est un seul diverticule qui saigne, mais quand on fait l'endoscopie au moment du saignement, c'est très difficile de localiser le diverticule qui saigne, sauf s'il y a un saignement actif au niveau de ce diverticule. Classiquement, l'hémorragie diverticulaire est à début brutal.

(14:10 - 14:16)

Elle n'est pas associée à des douleurs abdominales. Rarement, c'est un type de méléna. Souvent, c'est des rectoragies.

(14:16 - 14:34)

C'est tout simplement parce que les diverticules du côlon droit sont beaucoup plus rares que les diverticules du côlon gauche. Parfois, elle peut nécessiter une prise en charge en urgence puisqu'elle peut être responsable d'un état de choc. Mais souvent, c'est une hémorragie qui est bien tolérée par les patients.

(14:36 - 15:05)

Comment on va diagnostiquer tout ça, surtout en cas d'hémorragie ? C'est la coloscopie et également l'artériographie. Quand on fait une endoscopie après l'hémorragie, on va trouver que plusieurs diverticules sont sièges de cailloux sanguins, mais on ne peut pas visualiser le diverticule qui saigne. Par contre, quand on assiste au saignement actif d'un seul diverticule, on peut localiser le diverticule hémorragique.

(15:05 - 15:33)

Donc, on va s'aider d'une artériographie quand on est dans cette situation-là. En cas d'infection, la symptomatologie clinique et biologique, même si elle est peu spécifique, va permettre de suspecter le diagnostic en associant la douleur abdominale de l'infociliaire, la fièvre, les troubles du transit et surtout si le patient est connu porteur d'une diverticulose. Sinon, l'imagerie, surtout la TDM, va permettre d'affirmer le diagnostic.

(15:34 - 16:07)

Donc, l'ASP, le lavement aux hydrosolubles, n'ont pas de place. Mais comme j'ai dit, c'est la TDM avec opacification vasculaire qui est l'examen de référence et qui va nous permettre de localiser les diverticules, de voir leur taille, leur nombre et aussi de rechercher et d'étudier les tissus

péricoliques et donc à la recherche d'abcès, à la recherche de fistules. Donc, c'est ça l'intérêt de la TDM, puisque comme le montre cette image, on voit bien, elle permet de visualiser les diverticules, on voit leur nombre et on voit leur localisation.

(16:09 - 16:44)

On peut aussi voir les complications, les fistules, les connexions abcédées, l'existence de perforations de la paroi. Donc, une fois qu'on a diagnostiqué ces maladies diverticulaires, qu'elles soient complications infectieuses ou hémorragiques, l'hospitalisation s'impose. Donc, en cas de diverticulite aiguë, il faut commencer un traitement antibiotique qui va associer de l'amoxicilline acide clavulamique, mais on peut aussi utiliser du fluoroquinolone, s'il y a une contre-indication à l'utilisation de l'amoxicilline.

(16:44 - 17:02)

C'est un traitement qui va durer de 7 à 10 jours. Donc ça, c'est la diverticulite aiguë. Le traitement doit être débuté par voie intraveineuse jusqu'à obtenir la pérexie et la symptomatologie, et le patient devient asymptomatique sur le plan immunitaire.

(17:03 - 17:32)

Cette prise en charge va en fonction de la fameuse classification. On va distinguer les patients qui ont des abcès de plus ou de moins de 3 cm pour discuter la faisabilité ou non d'un drainage radiologique et l'indication surtout d'un drainage radiologique. Tout ça, c'est pour les stades 1 et 2. Pour les stades 3 et 4, c'est soit le drainage chirurgical, soit par voie celluloscopique, soit une chirurgie par laparotomie.

(17:35 - 18:03)

La grande discussion se fait chez les patients qui ont déjà fait une maladie diverticulaire, l'indication de faire un traitement chirurgical à froid et on parle d'un traitement prophylactique. Là, c'est vraiment une grande controverse parce que la plupart des auteurs ne sont pas d'accord pour faire cette chirurgie prophylactique. Ça reste quand même un geste agressif, même si actuellement on fait ce geste par laparoscopie.

(18:03 - 18:39)

C'est pour ça qu'il faut sélectionner les indications pour discuter de cette chirurgie prophylactique à froid. Cette colectomie prophylactique sera indiquée, surtout chez les sujets qui ont un haut risque de récurrence, c'est-à-dire qui présentent une forme compliquée, qui présentent des signes de gravité lors de la poussée. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de consensus concernant les patients jeunes qui ont une première poussée non compliquée et le bénéfice réel, même après deux ou trois poussées, chez les autres patients, n'est pas bien démontré.

(18:40 - 19:25)

Les examens, bien sûr, avant de discuter de cette chirurgie prophylactique, il faut obligatoirement avoir une endoscopie totale pour faire l'inventaire des lésions, mais surtout pour rechercher s'il y a une autre pathologie sous-jacente. L'hémorragie diverticulaire, quant à elle, a beaucoup bénéficié de l'essor des traitements radiologiques et endoscopiques interventionnels des moustases. On peut traiter ces patients par des techniques endoscopiques, pose de clip, par exemple, ou embolisation radiologique, au lieu d'avoir recours au traitement chirurgical, qui reste quand même indiqué en cas d'échec de ces techniques endoscopiques et radiologiques.

(19:28 - 19:40)

Pour conclure, la diverticula oscolique non compliquée est une anomalie anatomique et non une maladie. Elle ne nécessite aucune prise en charge particulière. Sa prévalence augmente avec l'âge.

(19:40 - 20:13)

Sa visiopathologie reste imparfaitement expliquée, même s'il y a un certain nombre d'hypothèses qui vont s'associer pour expliquer la formation de ces diverticules. Les complications infectieuses sont les plus fréquentes, puisqu'elles peuvent concerner jusqu'à 25 % des patients porteurs de diverticulose. L'âge élevé des patients, l'existence de signes de gravité radiologiques sur la TDM sont les principaux facteurs de risque des mauvais pronostics en cas de poussée diverticulaire.

(20:13 - 20:35)

L'autre complication, c'est la complication hémorragique, qui, elle, concerne 10 % des patients porteurs de diverticulose COVID. Ces complications infectieuses et hémorragiques définissent ce qu'on appelle la maladie diverticulaire. Il faut donc faire la distinction entre une diverticulose COVID et une maladie diverticulaire.

(20:36 - 20:37)

Je vous remercie.